

УДК: 616-65-08

Ж.С.Мамбетов, Д.Ж.Оморов
Республиканский научный центр урологии
при Национальном госпитале МЗ КР

Тактика лечения больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, сочетающейся с геморроем

В статье отражен тактический подход лечения у 30 больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, сочетающейся с геморроем. При этом обращено внимание к тактике лечения в зависимости от осложнений геморроя – тромбозом (15 чел.) и кровотечением из геморроидальных узлов (15 чел.), а также отражена клиническая динамика на фоне терапии.

Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, геморрой, тромбоз, кровотечение из геморроидальных узлов, лечение.

Введение. Выбор лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) в сочетании с геморроем требует нового подхода с учетом ряда узловых моментов. Если по отношению ДГПЖ тактика остается неизменной в основных принципах хирургического лечения, то по отношению к осложненной форме геморроя тактические подходы изменяются [1,2,3].

Следовательно, в этой статье были рассмотрены подходы предоперационной подготовки больных, профилактические и лечебные мероприятия по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы в сочетании с геморроем и динамика клинических показателей, полученные результаты станут рекомендательными методами для практических врачей.

Материал и методы исследования. Клиническим материалом были 30 пациентов с ДГПЖ в сочетании с осложненным геморроем, которые находились на стационарном лечении в отделении проктологии Республиканского научного центра урологии при Национальном госпитале Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

Использованы опросники для оценки симптоматики ДГПЖ по шкале IPSS. На основании наружного осмотра и анаскопии установлены локализации геморроидальных узлов и их характеристика от вида осложнений.

Результаты и их обсуждение. Выбор и объем оперативной тактики зависел от стадии геморроя и осложнений, которые были следующие: тромбоз наружных геморроидальных узлов у 15 больных с ДГПЖ. Из анамнеза было установлено возникновение периаанальной гематомы, т.е. тромбированного геморроидального узла, чему способствовали физический труд и занятие спортом в сопровождение с простудным фактором (4 пациента); запоры (7 больных); жидкий стул (1 пациент), а у остальных двух пациентов он развился после приема алкогольных напитков (водки).

Наряду с этим было установлено, что с момента возникновения периаанальной гематомы обратились за 1 сутки – 3 пациента, через 2 и 3 дня – 8, более 3-х суток – 4 пациента. Следовательно, высокий удельный вес обращаемости на 2, 3 и более суток, больные надеялись, что болезнь может самостоятельно разрешиться и не

придавали ей внимание. Это обстоятельство считается не лучшим в отношении клинического статуса больных, течения и объемных затрат в лечении. Здесь уместно отметить, что временной фактор играет важную роль, т.е. чем раньше начато лечение, тем больше залог быстрого купирования острого процесса.

Из числа обратившихся за медицинской помощью больных с тромбозом геморроидальных узлов, предъявляли жалобы на боль в заднем проходе постоянного характера, усиливающиеся при нагрузке, в акте дефекации – у 13 человек и только 2 пациента ощущали дискомфорт (инородного тела) в анальной области.

У 15 больных с периаанальной гематомой (тромбозом геморроидальных узлов) впервые проявлялась анамнестически и имела место следующая статусная характеристика: одиночный тромбированный наружный узел (периаанальная гематома), который локализован под кожей периаанальной области: на 3 ч – 2; на 4 ч – 2; на 5 ч – 3; на 6 ч – 1; на 7 ч – 4; на 9 ч – 1; на 11 ч – 2.

Из локализации 12 гематом располагалась в задне-левом из 3 секторов периаанальной области, т.е. с 3 до 7 ч, а 3 тромбированного узла на 9 и 11 ч определялись в правом секторе.

Средний статистический первичный осмотр – у всех 15 больных диаметр периаанальной гематомы в анальной области составлял $15,8 \pm 1,2$ мм.

Клинически положительная обратимость периаанальной гематомы отмечена на 5 и 7 сутки после начатого лечения, а начальный регресс был зарегистрирован уже в 3 сутки исходного.

После 10-дневной инъекционной терапией токсивенолом, в дальнейшем проходил таблетизированный прием лекарства, а также местными тампонами троксевазинового геля, тромбированные узлы уменьшились более чем наполовину – $7,3 \pm 2,7$ мм ($p < 0,05$). В данном случае прием ректальных свеч был исключен из-за болезненности при введении, и исключении механических травм на тромбированные геморроидальные узлы.

Следует заметить, что ни в одном случае с момента обращения до окончания лечения не отмечались характерные осложнения периаанальной гематомы – некротических изменений кожи над узлом и последующей экстррузии сгустка.

Из числа больных ДГПЖ с тромбозом геморроидального узла в 2 случаях сопровождалось с ОЗМ и им были произведены на 1 этапе – трокарная цистостомия при параллельной комбинированной терапий, а также применялась антикоагулянтная терапия пролонгированного действия курсовой продолжительностью 3 дня (первая в/м инъекционная доза составила 40 мг, а последующие два дня по 20 мг).

Наряду с выше указанной терапией тромбоза ге-

морроидального узла по поводу ДГПЖ, пациентам назначались селективные α -адреноблокаторы (омник, тамсопрост по 4 мг в день). Следовательно, наряду с клинической оценкой тромбированных геморроидальных узлов, больным проводился мониторинг за симптомом

нижних мочевых путей по шкале IPSS (основная группа – 13 чел.) и их результаты были сравнены с ДГПЖ без геморроя (контрольная группа – 15 чел.), а полученная динамика была представлена в следующей таблице 1.

Таблица 1 – Динамика симптомов ДГПЖ на фоне лечения

Параметры		Основная группа (n-13)	Контрольная группа (n - 15)
симптомы по IPSS	до лечения	23,5 + 1,8	18,6 + 1,4
	после лечения	10,2+1,9*	9,3+1,7*
ноктурия (ICS)	до лечения	3,4 + 1,6	3,3 + 1,2
	после лечения	1,7+0,3	0,2+0,6**
показатель качество жизни (QOL)	до лечения	4,4 + 1,8	4,6 + 1,2
	после лечения	2,1+1,2	1,3+0,9**
Примечание: * $p<0,05$; ** $P <0,01$			

Значительные улучшения были в контрольной группе, нежели в основной группе. Так, положительная динамика зарегистрирована во всех параметрах после лечения от исходного уровня, в сравниваемых группах отмечены достоверные результаты ($p<0,05$) и имело место снижение частоты ночных мочеиспусканий, что оказало положительную динамику в показателе качества жизни ($p<0,01$). Из сказанного следует, что ощутимая положительная динамика симптоматологических показателей лиц ДГПЖ без геморроя по сравнению с больными ДГПЖ в сочетании с геморроем объясняется тем, что видимо в первом случае взаимоотношающего патологического фактора не присутствовало. Из сказанного следует, что устранение геморроя на этапе лечения больных с ДГПЖ имеет важное патофизиологическое значение.

В дальнейшем из числа больных после купирования перианальной гематомы перенесли операцию аденомэктомии 7 человек, а 8 пациентам наоборот произведены геморроидэктомия. В данном случае следует руководствоваться «превалирующей симптоматикой болезни», т.е. чем больше они выражены, тем больше показателей к первостепенному оказанию помощи, но здесь необходима обязательная медикаментозная защита от прогрессирования или осложнения от фонового заболевания (геморроя или ДГПЖ).

Следует отметить, что у лиц после установления троакарной цистостомы лечение проводилось в специализированном проктологическом отделении (Национальный госпиталь МЗ КР), а остальные пациенты были консультированы врачами урологами на предмет параллельно протекающей ДГПЖ.

Во 2-ю группу (анальные кровотечения) вошли 15 больные, им в процессе обследования в обязательном порядке произведены ректороманоскопия и аноскопия для установления топической локализации кровотечения в изолированном одном узле или в двух и более геморроидальных узлах. При ректороманоскопии не определились глубинные кровотечения из органических или других патологических образований в осмотренных отделах кишки.

Аноскопия показала, что у больных с анальными кровотечениями у 8 - отмечены из одного геморроидального узла локализованной 7 часах по циферблату, в 4 случаях из двух узлов с локализацией на 3 и 7 часов и из трех узлов было установлено 3 случая. Следует заметить, что у 12 из 15 человек выявлены подслизистые геморрагии в области внутренних геморроидальных узлов.

На фоне проведенной терапии по выше рекомендованной схеме значительное снижение кровотечения из анального канала было в 4 случаях, полное прекращение достигнуто – в 9 и в 2 случаях было снижение интенсивности кровотечения, без постоянного характера.

Следует заметить, что с течением времени после терапии на 7 и 10 сутки желаемый лечебный эффект был достигнут у 14 пациентов и только лишь в одном случае из-за неэффективности терапии (эпизодические выделения крови на 6, 9, 12-й день после применения препарата) было наложено в кровоточащий геморроидальный узел латексное кольцо.

Таким образом, через 10 дней после комбинированной терапии местного применения троксевазинового геля, геморроидальных свечей проктозана и в/м инъекций токсивенола число пациентов с геморроидальными кровотечениями достоверно уменьшилось ($p<0,01$).

В процессе терапевтического лечения в обеих группах в нашу задачу не входила цель нормализации стула с помощью пищевых добавок или препаратов, улучшающих перистальтику кишечника, ферментов и эубиотиков, изменяющих флору толстой кишки. В случае запоров предложено изменение режима питания с преимущественным приемом пищевой клетчатки и увеличение объема ежедневно потребляемой жидкости.

Выводы: В обеих группах после лечения боль в области заднего прохода уменьшилась, появился значительный регресс, особенно это имело место в группе больных с перианальной гематомой. Статистически достоверное уменьшение размера тромбированных узлов после 10 дней комбинированного лечения приводит к уменьшению перианального отека и соответственно к исчезновению болевого синдрома.

Следует отметить, что достоверной разницы в числе больных, предъявлявших жалобы на зуд при первичном осмотре, в обеих группах не выявлено.

Число больных, предъявляющих жалобы на боли, жжение и зуд в заднем проходе после 10-дневного предложенного лечения заметно уменьшилось и стало не постоянного характера.

По нашему мнению, под действием применяемых препаратов за счет улучшения венозного тонуса и улучшения микроциркуляции, происходит снижение местно-

го воспалительного процесса с уменьшением застойного отека перианальных тканей. Немаловажный лечебный фактор оказывает прямое местное действие троксевазина (гель) через кожу, уменьшая экссудацию при воспалении, нормализуя проницаемость и тонус кровеносных сосудов, стимулируя регенерацию поврежденных тканей.

Из этого следует, что выше перечисленную комбинированную терапию следует широко применять в клинической практике.

Список литературы

1. Базаев В.В. Пути улучшения результатов лечения больных аденомой предстательной железы // В.В. Базаев // Автореф. дис. ... докт. мед. наук: 14.00.40. - М., 1992. - 41 с.

2. Камалов А.А., Гуцин, С.Д., Дорофеев. Современные аспекты оперативного лечения доброкачественной гиперплазией предстательной железы // Урология. - 2004. - №1. - С. 30-34.

3. Мудров А.А. Консервативное ведение больных хроническим геморроем // Справочник поликлинического врача. - 2008. - №4. - С. 75-76.

Тұжырым

Ж.С.Мамбетов, Д.Ж.Оморов

ҚР ДСМ Мемлекеттік госпиталінің қарамағындағы
Республикалық урология зерттеу орталығы

Summary

J.S. Mambetov, D.J. Omorov

Republican Scientific Center of Urology at the National
Hospital of the MH KR

Қуықасты безінің қатерсіз гиперплазиясымен геморрой қосарланған науқастарды емдеу тәсілі

Бұл мақалада геморроймен қосарланған қуықасты безінің қатерсіз гиперплазиясымен 30 науқастарды емдеу тәсілі көрсетілген. Сонымен бірге, геморройдың асқынуларына байланысты ем тәсіліне көңіл бөлінген - тромбоз (15 науқас), геморройдалды түйіндерден қансырау (15 науқас) және ем барысындағы клиникалық динамикасы көрсетілген.

Түйінді сөздер: қуықасты безінің қатерсіз гиперплазиясы, геморрой, тромбоз, геморройдалды түйіндерден қансырау, ем.

The tactics of treatment of patients with benign prostatic hyperplasia, matching with hemorrhoids

This article reflects the tactical approach of treatment in 30 patients with benign prostatic hyperplasia, matching with hemorrhoids. At the same time drawn attention to the tactics of treatment depending on the complications of hemorrhoids-thrombosis (15 pers.) And bleeding from hemorrhoids (15 pers.), and is also reflected in the dynamics of clinical therapy.

Key words: benign prostatic hyperplasia, hemorrhoids, thrombosis, bleeding from hemorrhoids, treatment.